

Die Erstellung von Leitlinien

ÖNORM K 1920

LEITLINIEN

Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen und haben Empfehlungscharakter. Sie sollten die Leistungsträger im Gesundheitswesen in der Entscheidungsfindung unterstützen, aber auch als Informationsquelle für Leistungsempfänger und Öffentlichkeit dienen. Leitlinien werden patientenorientiert erstellt.

Um Leitlinien zu erstellen sollten sich österreichische Institutionen an der ÖNORM K 1920 orientieren.

Durch Leitlinien wird die beste Evidenz zu Prävention, Diagnostik, Prognose, Therapie und Nebenwirkungen bzw. Komplikation und Kostenwirksamkeit explizit identifiziert, bewertet und zusammengefasst.

Evidenzbasierte Strategie der Leitlinienentwicklung

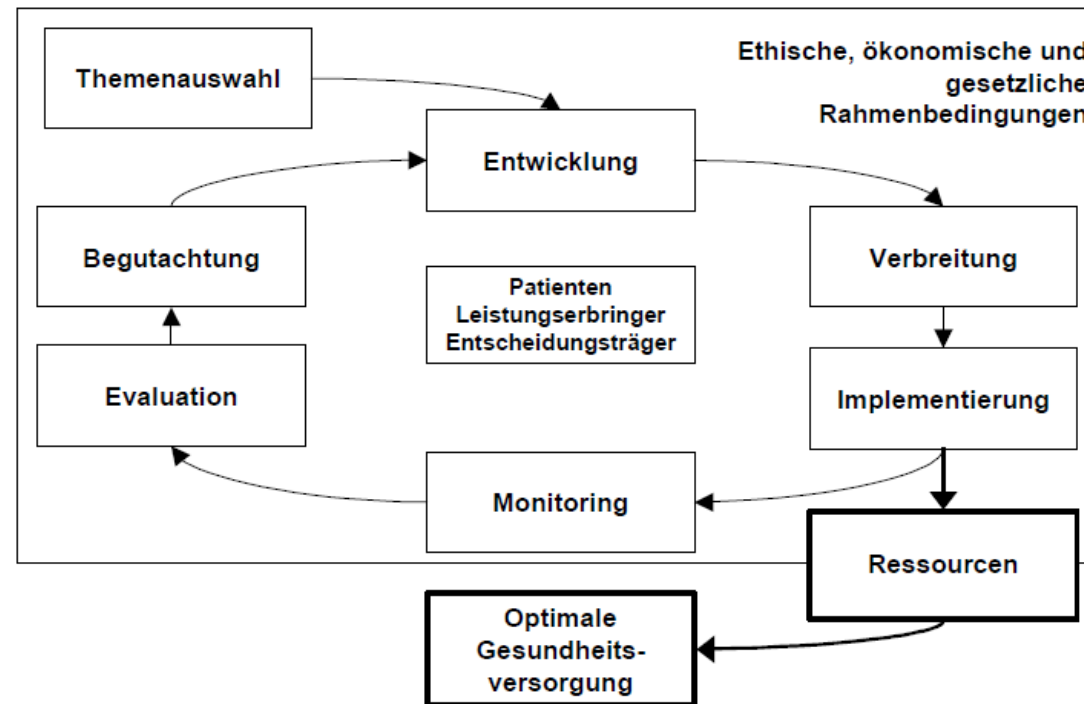
Systematische Recherche und Bewertung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz

Verknüpfung der Empfehlungen mit der Evidenz

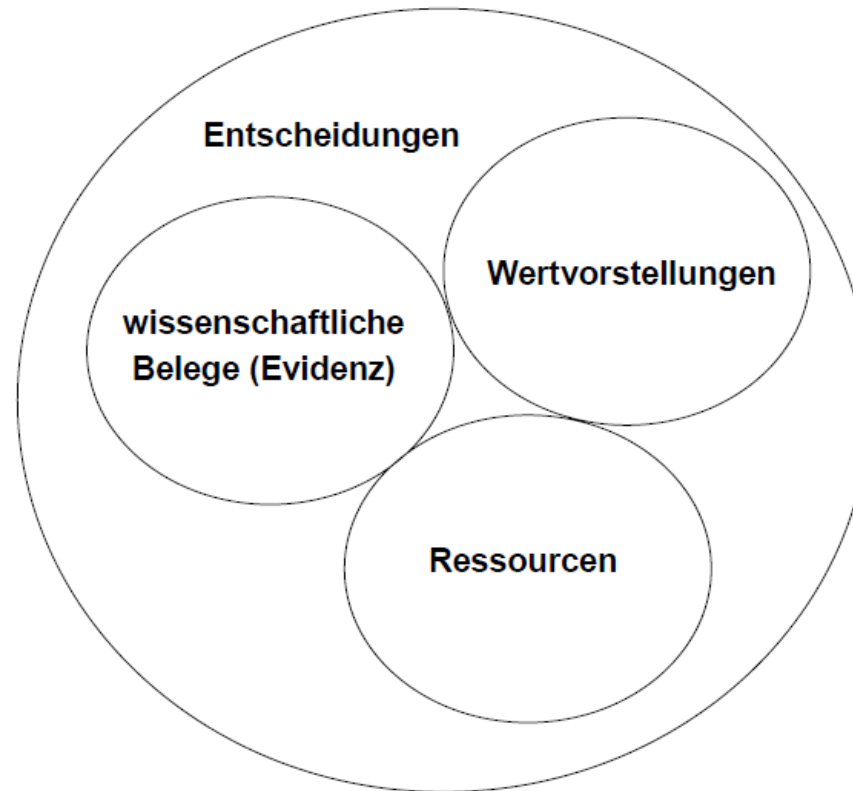
formalisierte Konsensverfahren

Dokumentation des Verfahrens

Erstellung und Nutzung von Leitlinien



Elemente von Gesundheitsentscheidungen



Methodik medizinischer Leitlinien - Europarat-Empfehlung Rec (2001)13 – Abbildung 2: Elemente von Gesundheitsentscheidungen (in Anlehnung an Muir Gray, 1997)

ÖNORM K 1920

- Auszüge

Anwendungsbereich

Diese ÖNORM legt die Anforderungen an die systematische Entwicklung, den strukturellen Aufbau, die Disseminierung, die Implementierung und die Qualitätssicherung von Leitlinien fest. Die ÖNORM ist in allen Bereichen des Gesundheitswesens anwendbar, sie ist weder spezifisch für medizinische Disziplinen noch berufsgruppenspezifisch. Die ÖNORM sollte als Grundlage für alle Arbeitsgruppen im Gesundheitswesen dienen, die sich mit Arbeit an Leitlinien befassen.

Basis für diese ÖNORM bilden die Definitionen und beschriebenen Methoden des Guidelines International Network (G-I-N), des AGREE-Instruments , des Leitlinien-Manuals von ÄZQ und AWMF und der Empfehlungen des Europarates Rec (2001)13.

Entwicklung von Leitlinien I

In die Entwicklung einer Leitlinie sind alle betroffenen Personengruppen einzubinden. Die Leitlinienentwicklung sollte den Regeln der evidenzbasierten Medizin (EbM) folgen. Bestehende oder mögliche Interessenskonflikte sind in geeigneter Form anzusprechen. In der Gruppe der Leitlinienentwickler sollten alle betroffenen Berufsgruppen, Fachdisziplinen und Patientengruppen vertreten sein. Die Ansichten und Präferenzen der Patienten sind zu ermitteln und sollten Eingang in die Leitlinienentwicklung finden.

Entwicklung von Leitlinien II

In der Leitlinie sind die Anwenderzielgruppen eindeutig zu definieren. Insbesondere ist zu erklären, welche Fach- und Berufsgruppen aus ambulanter und stationärer Versorgung, welche anderen Leistungserbringer, Patienten sowie Entscheidungsträger im gesundheitspolitischen Bereich (z.B. bei Nutzung von in der Leitlinie festgelegten Qualitätsvorgaben) zur Anwenderzielgruppe gehören.

Die Entwicklung von Leitlinien hat evidenzbasiert zu erfolgen. Bei der Suche nach Evidenz sind systematische Methoden anzuwenden. Die Suchstrategie für die Identifizierung von Evidenz muss detailliert beschrieben werden. Die Identifizierung der Evidenz hat nach einem systematischen und expliziten Analyse- und Bewertungsverfahren zu erfolgen. Leitlinien dürfen in keinem Fall auf der Grundlage unsystematischer Literaturrecherche erstellt oder ausschließlich als Resultat von Expertenkonsens zustande gekommen sein.

Entwicklung von Leitlinien III

Leitlinien müssen sich auf die beste verfügbare Evidenz (wissenschaftliche Erkenntnisse und klinische Ergebnisdaten) stützen. Die Kriterien für den Ein- und Ausschluss der identifizierten Evidenz werden in der Leitlinie explizit beschrieben und begründet.

Die Methoden, die zur Formulierung der Leitlinie verwendet wurden, sind in der Leitlinie explizit zu beschreiben (Abstimmungsverfahren, formale Entscheidungsfindungsprozesse und dgl.)

Die Leitlinie muss Informationen über die Berücksichtigung von Nebenwirkungen und Risiken der Empfehlungen beinhalten.

Die Grundlagen der einzelnen Empfehlungen einer Leitlinie sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Für den Anwender muss zu jeder einzelnen Empfehlung der Härtegrad der Evidenz (level of evidence) nach einem anerkannten Klassifizierungsverfahren erkennbar sein.

Entwicklung von Leitlinien IV

Die Darlegung, dass keine Beeinflussung der Arbeit der Leitlinienautoren und der Empfehlungen stattgefunden hat, ist integrierter Bestandteil einer Leitlinie. Jede Form der direkten oder indirekten finanziellen Unterstützung der Leitlinienentwicklung muss explizit angegeben werden. Weiters muss ersichtlich sein, ob neben den finanzierenden Organisationen weitere Interessenten (z.B. Behörden, Fachgesellschaften, Firmen als Auftraggeber) ergänzend zu den Autoren oder Herausgebern beteiligt waren.

Interessenskonflikte von Mitgliedern der Leitlinienentwicklungsgruppe sind darzulegen. Die Leitlinie enthält Informationen darüber, dass sich alle Autoren zu möglichen Interessenskonflikte geäußert haben.

Struktur von Leitlinien I

Bei Anwendung einer Leitlinie ist die exakte Zielsetzung zu berücksichtigen. Jede neu erstellte Leitlinie hat die angeführten Strukturmerkmale zu enthalten.

Das Gesamtziel und gegebenenfalls die Teilziele der Leitlinie sind darzustellen, besonders der durch die Leitlinie beabsichtigte gesundheitliche Nutzen.

Die konkreten, der Leitlinienentwicklung zugrunde liegenden medizinischen Fragestellungen sind in der Leitlinie anzuführen.

Die Patientenzielgruppe der Leitlinien muss genau beschrieben sein. Dabei ist auf Kriterien wie Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, Komorbidität und Schweregrad der Erkrankung Bedacht zu nehmen.

Struktur von Leitlinien II

Jede Empfehlung der Leitlinie enthält konkrete Angaben darüber, welches Vorgehen in einer bestimmten Situation für eine bestimmte Patientengruppe angemessen ist und stellt die zugrunde liegende Evidenz dar.

Zu jeder Empfehlung der Leitlinie werden die vorhandenen Handlungsalternativen benannt.

Die Schlüsselempfehlungen einer Leitlinie müssen für deren Anwender leicht erkennbar sein.

Disseminierung und Implementierung von Leitlinien I

Leitlinien müssen den Zielgruppen in kurzer Zeit und umfassend bekannt gemacht werden. Die Leitlinie sollte Hinweise enthalten, die die Abschätzung des Aufwandes bei Implementierung der Leitlinie ermöglichen.

In einer Pilotphase vor der Veröffentlichung einer Leitlinie sollte diese innerhalb der geplanten Anwendergruppe einer praktischen Validierung (Testphase) unterzogen werden.

Der Implementation einer Leitlinie geht die Phase der Disseminierung voraus. Die Leitlinie sollte gemeinsam mit unterstützendem Material wie Zusammenfassungen, Fortbildungsmaterial, Unterlagen für den Patienten oder EDV-basierten Lernprogrammen an die Zielgruppen verteilt werden. Der ungehinderte Zugang zum Volltext der Leitlinie ist durch geeignete Maßnahmen (Downloads, Publikationen) sicherzustellen.

Disseminierung und Implementierung von Leitlinien II

Die Implementierung einer Leitlinie kann organisatorische Änderungen innerhalb einer Gesundheitseinrichtung oder an der Übergangsstelle zwischen Gesundheitsdienstleistern erfordern. Besonders Übergänge zwischen Versorgungsebenen sind in der Leitlinie klar anzusprechen.

Bei der Erstellung einer Leitlinie sind die Auswirkungen auf die Ressourcen zu diskutieren und offen zu legen. Dies kann sowohl zusätzlich notwendige Ressourcen wie z.B. Personal, Geräte oder Verbrauchsgüter, wie auch mögliche Einsparungspotentiale in den genannten Kostengruppen beinhalten.

Qualitätssicherung von Leitlinien I

Leitlinien durchlaufen vor der Veröffentlichung eine Begutachtungsphase. Leitlinien müssen in definierten Zeitabständen aktualisiert werden.

Vor der Publikation einer Leitlinie ist diese einem externen Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Als Gutachter sind Experten aus dem medizinischen Bereich, unterstützende Methodiker (z.B. Biostatistiker) sowie Patientenvertreter heranzuziehen, die nicht an der Leitlinienentwicklung beteiligt waren. Der Evaluierungsprozess ist in geeigneter Form zu dokumentieren. Insbesondere sind Aufzeichnungen über die verwendete Methodik und die Ergebnisse der Evaluation zu führen. Eine Liste der beteiligten Gutachter mit Angaben zur Angehörigkeit in Organisationen, Berufsverbänden, Interessenvertretungen und dgl. ist anzulegen.

Qualitätssicherung von Leitlinien II

Die Leitlinie sollte Angaben zur Aktualisierung der Inhalte enthalten. Die Vorgehensweise und ein definierter Zeitplan sind klar darzulegen. Die Aktualisierung kann auch durch eine ständige Arbeitsgruppe, die Literaturrecherchen und Evaluierungsberichte aus der Anwenderpraxis entgegennimmt, vorgenommen werden. Zu diesem Zweck sollten Evaluierungskriterien definiert werden, die, ausgehend von den Kernempfehlungen der Leitlinie, geeignet sind, die medizinische Wirksamkeit der Leitlinienanwendung zu belegen.

Leitlinie AWMF (S1-3)

Nach dem System der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) werden Behandlungs-Leitlinien in drei Entwicklungsstufen von S1 bis S3 entwickelt und klassifiziert, wobei S3 die höchste Qualitätsstufe ist.

- S1: von einer Expertengruppe im informellen Konsens erarbeitet
 - S2: eine formale Konsensfindung oder eine formale „Evidenz“-Recherche hat stattgefunden
 - S3: Leitlinie mit zusätzlichen/allen Elementen einer systematischen Entwicklung (Logik-, Entscheidungs- und „Outcome“-Analyse, Bewertung der klinischen Relevanz wissenschaftlicher Studien und regelmäßige Überprüfung)
-